

Nome: ALEXANDRE RODOLFO APARECIDO DA
COSTA

Data de Nascimento: 20-2-1978

IMC: 41,23

Sexo: Masculino

Data do exame: 05-09-2017

Peso: 115 kg

Altura: 1,67 m

Medico: DR. PAULO CESAR DE CARVALHO

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 05-09-2017, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 457,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 11,5 e 138,5 minutos. O tempo total de sono foi de 385,5, eficiência de 84,3% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,5%; estágio N2: 67,6%; estágio N3: 9,3%; sono REM: 19,6%. O índice de despertares foi de 56,8/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 84,5, sendo elas 356 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 187 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e mínima de 54%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 60 - 102 bpm e NREM de 59 - 102 bpm. O paciente roncou.

CONCLUSÃO: *Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (13), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:*

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 84,5/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=54%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

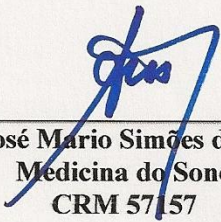
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

